



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI LABORATORIUM
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1038.2/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium

Penanggung Jawab :



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kep.,AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium Rumah Sakit ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Instalasi Laboratorium merupakan salah satu unit pelayanan penunjang medis yang memiliki peran penting dalam mendukung penegakan diagnosis, penentuan tindakan medis, pemantauan terapi, serta evaluasi kondisi pasien. Dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium diperlukan sistem organisasi yang jelas, efektif, efisien, dan terintegrasi guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga yang bertugas di Instalasi Laboratorium dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan tata hubungan kerja sesuai dengan standar profesi, kebutuhan pelayanan rumah sakit, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku. Pedoman ini juga bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang baik antarunit, meningkatkan efektivitas pelayanan, mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta menjamin kepatuhan terhadap aspek proteksi radiasi dan keselamatan kerja.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelayanan laboratorium dapat bekerja secara profesional, terkoordinasi, dan bertanggung jawab sehingga pelayanan laboratorium yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan pasien serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan rumah sakit.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan pelayanan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium Rumah Sakit ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pelayanan Laboratorium yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasuruan, 1 Desember 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes.,AFP
2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

PENYUSUN :

1. dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS
2. Elza Safarina Ulfa, AMd.AK
3. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

PERATURAN DIREKTUR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT 3

 2.1 Deskripsi Rumah Sakit Prima Husada 3

 2.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Prima Husada 3

BAB III VISI, MISI, NILAI BUDAYA, MOTTO RUMAH SAKIT 4

 3.1 Visi..... 4

 3.2 Misi 4

 3.3 Falsafah..... 4

 3.4 Nilai Budaya 4

 3.5 Motto 4

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI 5

 4.1 SOTK Rumah Sakit 5

 4.2 SOTK Instalasi Laboratorium..... 5

BAB V URAIAN JABATAN 6

 5.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 6

 5.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 8

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA..... 13

BAB VII POLA KETENAGAAN 15

 7.1 Ketentuan Umum..... 15

 7.2 Analisa Beban Kerja 15

BAB VIII PROGRAM ORIENTASI 17

 8.1 Orientasi Umum Rumah Sakit 17

 8.2 Orientasi Khusus 17

BAB IX PERTEMUAN/RAPAT 20

 9.1 Jenis Rapat..... 20

 9.2 Pelaksanaan Rapat 20

BAB X PELAPORAN 21

BAB XI PENUTUP..... 22

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia..... 6

Tabel 5.2.1 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang..... 8

Tabel 7.2.1 Analisa Beban Kerja 15

Tabel 8.2.1 Materi Orientasi Khusus..... 17



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1038.2/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI LABORATORIUM

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Instalasi Laboratorium yang aman, efektif, efisien, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien dan keselamatan kerja, diperlukan pengorganisasian Instalasi Laboratorium yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kompetensi sumber daya yang tersedia;
- b. bahwa pengorganisasian Instalasi Laboratorium harus mampu mendukung pelaksanaan tata kelola klinis, tata kelola organisasi, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, proteksi radiasi, serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
11. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02./D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;



13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika
Nomor :1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
LABORATORIUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- (2) Instalasi Laboratorium adalah unit kerja fungsional di rumah sakit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan pelayanan laboratorium;
- (3) Pelayanan laboratorium adalah seluruh kegiatan pemeriksaan laboratorium yang meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik untuk membantu penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan, penentuan prognosis, dan pencegahan penyakit;
- (4) Kepala Instalasi Laboratorium adalah tenaga profesional yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium;
- (5) Dokter Spesialis Patologi Klinik adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik dan memiliki kompetensi dalam interpretasi hasil laboratorium, konsultasi laboratorium, pengawasan mutu, serta pengembangan pelayanan laboratorium;
- (6) Dokter Spesialis Patologi Anatomi adalah dokter spesialis yang berwenang melakukan pemeriksaan jaringan, sitologi, dan pemeriksaan patologi anatomi lainnya untuk membantu penegakan diagnosis penyakit;
- (7) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan laboratorium pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik sesuai dengan kewenangan profesinya.

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit memiliki identitas organisasi yang meliputi nama rumah sakit, kepemilikan, klasifikasi rumah sakit, alamat, wilayah



pelayanan, kapasitas tempat tidur, jenis pelayanan, serta sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- (2) Deskripsi dan sejarah Rumah Sakit digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategis, pengembangan organisasi, penyelenggaraan pelayanan, peningkatan mutu, keselamatan pasien, serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit;
- (3) Informasi mengenai deskripsi dan sejarah Rumah Sakit wajib dipelihara, diperbarui, dan didokumentasikan secara berkala sesuai dengan perkembangan organisasi dan pelayanan rumah sakit.

BAB III

VISI, MISI, NILAI BUDAYA, MOTTO

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit memiliki visi, misi, nilai budaya, dan motto yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sebagai arah, landasan, dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pengembangan organisasi;
- (2) Visi, misi, nilai budaya, dan motto Rumah Sakit wajib disosialisasikan kepada seluruh staf, pasien, keluarga pasien, mitra kerja, dan pihak terkait lainnya melalui media komunikasi yang mudah diakses dan dipahami;
- (3) Visi, misi, nilai budaya, dan motto Rumah Sakit harus mendukung terwujudnya tata kelola rumah sakit yang baik, peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit disusun untuk menjamin terselenggaranya tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berorientasi pada mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesinambungan pelayanan Kesehatan;
- (2) Struktur organisasi Rumah Sakit sekurang-kurangnya menggambarkan hubungan koordinasi, garis komando, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit;
- (3) Setiap perubahan struktur organisasi harus ditetapkan melalui keputusan pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didokumentasikan sebagai bagian dari tata kelola organisasi.



BAB V UARAIAAN JABATAN

Pasal 5

- (1) Uraian jabatan disusun secara tertulis, terdokumentasi, dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pegawai wajib memahami dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan uraian jabatan yang telah ditetapkan;
- (3) Atasan langsung bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian jabatan oleh pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- (4) Setiap perubahan uraian jabatan harus didokumentasikan, disosialisasikan kepada pegawai terkait, dan ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku di rumah sakit.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Tata hubungan kerja mengatur hubungan kerja vertikal, horizontal, dan fungsional antar pimpinan, staf, komite, instalasi, unit pelayanan, serta unit pendukung lainnya di lingkungan rumah sakit;
- (2) Hubungan kerja vertikal dilaksanakan berdasarkan garis komando dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi rumah sakit untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pelaporan, dan pengawasan;
- (3) Hubungan kerja horizontal dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama antarunit kerja yang memiliki keterkaitan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan operasional rumah sakit;
- (4) Hubungan kerja fungsional dilaksanakan berdasarkan kesamaan fungsi, kompetensi, dan kebutuhan pelayanan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan mutu pelayanan.

BAB VII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 7

- (1) Pola ketenagaan disusun untuk menjamin tersedianya jumlah tenaga yang cukup, kompeten, dan berwenang guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang aman, bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- (2) Penyusunan pola ketenagaan dilakukan berdasarkan:
 - a. Analisis beban kerja;
 - b. Jenis dan volume pelayanan;
 - c. Tingkat risiko pelayanan;
 - d. Jam operasional pelayanan;
 - e. Kebutuhan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam;



- f. Perkembangan organisasi dan teknologi;
- g. Hasil evaluasi kinerja pelayanan.

BAB VIII PROGRAM ORIENTASI

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan program orientasi bagi seluruh pegawai baru, pegawai yang mengalami mutasi, tenaga kontrak, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di lingkungan rumah sakit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Program orientasi bertujuan untuk memastikan setiap individu memahami visi, misi, nilai budaya, kebijakan, peraturan, tata tertib, serta sistem pelayanan rumah sakit sehingga mampu melaksanakan tugas secara aman, efektif, dan sesuai standar yang berlaku;
- (3) Program orientasi dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dievaluasi sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit.

BAB IX PERTEMUAN/RAPAT

Pasal 9

- (1) Pertemuan dan rapat dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hal yang bersifat mendesak atau strategis;
- (2) Setiap pertemuan dan rapat harus memiliki agenda yang jelas, peserta yang relevan, serta tujuan yang terukur sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas;
- (3) Pertemuan dan rapat dipimpin oleh pejabat atau penanggung jawab yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- (4) Hasil pertemuan dan rapat wajib didokumentasikan dalam bentuk notulen atau berita acara.

BAB X PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap unit kerja di Rumah Sakit wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, program kerja, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) Laporan kinerja disusun berdasarkan data yang akurat, valid, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kepala Unit bertanggung jawab terhadap penyusunan, verifikasi, evaluasi, dan penyampaian laporan kinerja unit kepada atasan langsung sesuai jalur koordinasi yang berlaku;



- (4) Laporan kinerja unit disampaikan secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit, sekurang-kurangnya setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1152/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Desember 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR1038.2/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI LABORATORIUM

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI LABORATORIUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan laboratorium merupakan salah satu pelayanan penunjang medis yang memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium digunakan sebagai dasar dalam penegakan diagnosis, penentuan terapi, pemantauan perkembangan penyakit, evaluasi hasil pengobatan, serta upaya pencegahan dan deteksi dini berbagai penyakit. Oleh karena itu, pelayanan laboratorium harus diselenggarakan secara profesional, bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium yang optimal, diperlukan sistem pengorganisasian yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat. Pengorganisasian Instalasi Laboratorium yang baik akan mendukung koordinasi antar petugas, memperjelas alur pelaporan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta menjamin pelaksanaan pelayanan laboratorium sesuai standar profesi dan standar mutu yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang laboratorium, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, serta adanya kewajiban pemenuhan standar akreditasi rumah sakit, maka diperlukan pedoman yang mengatur struktur organisasi, uraian tugas, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja, dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium rumah sakit. Pedoman ini juga menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan, logistik, pengendalian mutu, keselamatan pasien, dan keselamatan kerja di lingkungan Instalasi Laboratorium.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium disusun untuk memberikan arah dan panduan bagi seluruh tenaga laboratorium dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penyelenggaraan pelayanan laboratorium dapat berjalan secara optimal, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium ini disusun berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan laboratorium klinik, persyaratan teknis rumah sakit, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium di rumah sakit. Dengan

demikian, pedoman ini diharapkan menjadi acuan yang komprehensif dalam penyelenggaraan dan pengembangan organisasi Instalasi Laboratorium yang profesional, berkualitas, dan berkesinambungan.

1.2 Maksud

1. Maksud

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium Rumah Sakit disusun sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit, Kepala Instalasi Laboratorium, dokter penanggung jawab laboratorium, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), tenaga administrasi, dan seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja secara terstruktur, terkoordinasi, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar akreditasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan Instalasi Laboratorium yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui pengorganisasian yang jelas sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing personel dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit..

3. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan struktur organisasi Instalasi Laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
- b. Menjelaskan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan di Instalasi Laboratorium.
- c. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar petugas laboratorium serta unit kerja terkait di rumah sakit.
- d. Menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium yang efektif, efisien, profesional, dan sesuai standar pelayanan laboratorium rumah sakit.
- e. Menjamin pengelolaan sumber daya manusia laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- f. Menjamin pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium secara berkesinambungan melalui penerapan Pengendalian Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).
- g. Menjamin terselenggaranya program keselamatan pasien dan keselamatan kerja di lingkungan laboratorium.
- h. Menjadi acuan dalam pengelolaan sarana, prasarana, peralatan, reagen, dan logistik laboratorium secara efektif dan efisien.
- i. Mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan laboratorium secara berkelanjutan.
- j. Mendukung penyediaan hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat, tepat waktu, terpercaya, dan bermanfaat dalam proses penegakan diagnosis, penatalaksanaan terapi, serta pemantauan kondisi pasien.
- k. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

2.1 Deskripsi Rumah Sakit Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan, Telepon (0343) – 6745000, Email ; sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com. www.rs-primahusada.com

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Umum, dalam tugasnya dibantu oleh para Kepala Instalasi dan Kepala Unit/ Kepala Ruang.

Rumah Sakit Prima Husada menyediakan beberapa pelayanan yang meliputi: pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 Jam, Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari ruang isolasi, Kelas I,II,III dan VIP, Instalasi Kamar Operasi, Intensive Care Unit, Hemodialisa, Pelayanan Poli Spesialis yang terdiri dari pelayanan spesialis anak, spesialis bedah, spesialis ortopedi, spesialis mata, spesialis THT, spesialis dermatologi venerologi, spesialis kesehatan jiwa, poli rehab medik, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis syaraf, spesialis urologi, spesialis bedah plastik, spesialis paru, pelayanan gigi dan mulut. Selain itu juga membuka pelayanan laboratorium dan BDRS dan pelayanan radiologi.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai public service. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Prima Husada

Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kami pun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Tahun 2018 | : | Pengajuan ijin Rumah Sakit Prima Husada |
| 27 Desember 2018 | : | Ijin operasional keluar. |
| 9 Januari 2019 | : | Rumah Sakit Prima Husada diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan. |
| 11 Januari 2019 | : | Rumah Sakit Prima Husada menerima pasien serta dilakukan bimbingan akreditasi. |
| 23 April 2019 | : | RumahSakit Prima Husada sudah melaksanakan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1. |

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI BUDAYA, MOTTO

3.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi:

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan amat, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 Falsafah

Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4 Nilai Budaya

7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

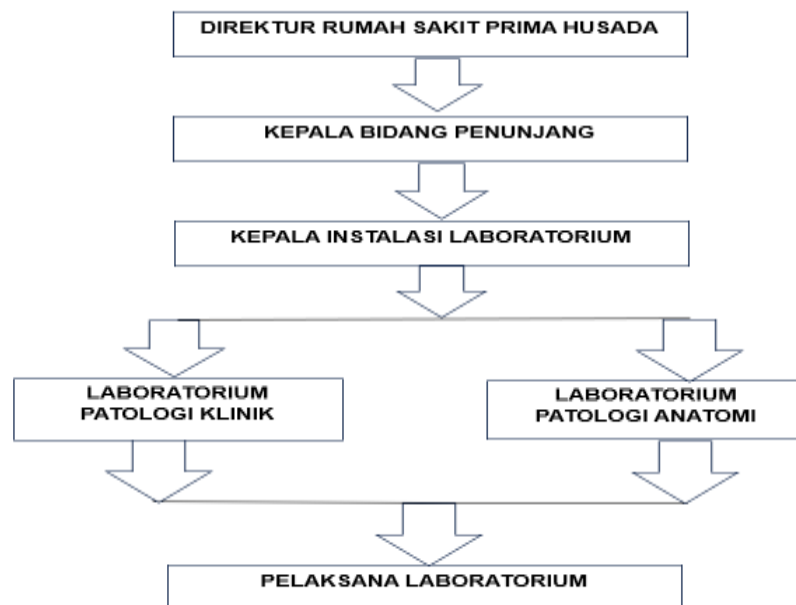
3.5 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”.

STRUKTUR ORGANISASI

[illegible]

4.2 Struktur Organisasi Tata Keloala Instalasi Laboratorium



5

BAB V

URAIAN JABATAN

5.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Tabel 5.1.1 Kulaifikasi Sumber Daya Manusia

No	Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi
1	Kepala Instalasi Laboratorium	• Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) atau Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) • Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. • Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan yang berlaku. • Memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) yang ditetapkan oleh rumah sakit.	• Pengelolaan operasional • Supervisi SDM • Mutu • Logistik • K3 dan PPI
2	Dokter Spesialis Patologi Klinik	• Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis Patologi Klinik/Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium. • Memiliki STR Spesialis Patologi Klinik yang masih berlaku. • Memiliki SIP sesuai tempat praktik. • Memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) yang ditetapkan melalui proses kredensial rumah sakit	• Kompetensi Profesional (Clinical Competency) • Kompetensi Diagnostik Laboratorium • Kompetensi Manajemen Laboratorium
3	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	• Lulusan pendidikan dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Anatomi pada institusi pendidikan yang diakui pemerintah. • Memiliki ijazah dokter spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA). • Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter spesialis yang masih berlaku. • Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai lokasi praktik dan ketentuan peraturan	• Melakukan pemeriksaan histopatologi. • Melakukan pemeriksaan sitopatologi. • Melakukan interpretasi dan validasi hasil pemeriksaan patologi anatomi. • Melakukan pemeriksaan frozen section. • Melakukan pemeriksaan FNAB dan interpretasinya.

		perundang-undangan yang berlaku. • Telah melalui proses kredensial dan memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege) yang ditetapkan oleh rumah sakit.	• Melakukan pemeriksaan imunohistokimia sesuai kompetensi dan fasilitas rumah sakit. • Menandatangani laporan hasil pemeriksaan patologi anatomi. • Memberikan konsultasi diagnostik kepada dokter penanggung jawab pasien
4	Kepala Ruang Laboratorium	• Pendidikan minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medis (D-III TLM), diutamakan Diploma IV atau Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. • Memiliki STR ATLM yang masih berlaku. • Memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan (SIPTK) atau ketentuan lain sesuai regulasi yang berlaku. • Memiliki pengalaman kerja di laboratorium minimal 3 tahun	• Pengelolaan operasional • Supervisi SDM • Mutu • Logistik • K3 dan PPI
5	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	• Pendidikan minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medis (D-III TLM). • Dapat berasal dari lulusan: ➤ D-III Teknologi Laboratorium Medis. ➤ D-IV Teknologi Laboratorium Medis. ➤ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. • Memiliki STR ATLM yang masih berlaku.	• Kompetensi pra analitik • Kompetensi analitik • Kompetensi pasca analitik • Pengendalian mutu dan keselamatan pasien

5.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tabel 5.2.1 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

No	Jabatan	Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
1	Kepala Instalasi Laboratorium	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Laboratorium terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Laboratorium. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Laboratorium b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan Laboratorium kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf di Instalasi Laboratorium untuk melaksanakan asuhan pelayanan pasien sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan asuhan pasien di Instalasi Laboratorium. 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan pasien yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Laboratorium yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Laboratorium terkait dengan

		kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab - Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya. - Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya - Kebenaran dan ketepatan pelaporan nilai kritis pasien kepada DPJP. - Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. - Kelancaran kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium. - Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan - Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya 3. Wewenang - Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. - Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di Instalasinya - Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan di Instalasi Laboratorium. - Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan. - Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
2	Kepala Ruang Laboratorium	1. Uraian Tugas - Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Radiologi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja Instalasi Laboratorium. - Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. - Menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Instalasi Laboratorium. - Melakukan analisis pola ketenagaan staf Laboratorium yang untuk memenuhi kebutuhan pasien dan pelayanan rumah sakit. - Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Laboratorium dan melaksanakannya. - Menjaga agar proses penyusunan dan pelaksanaan setiap kegiatan di Instalasi Laboratorium disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku.

		g. Menyusun dan evaluasi regulasi Instalasi Laboratorium h. Memastikan terlaksananya pelayanan Instalasi Laboratorium sesuai regulasi. i. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME). j. Memonitor dan mengevaluasi semua jenis pelayanan Instalasi Laboratorium k. Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas dan hal – hal terkait di unitnya. l. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. m. Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. 2. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. b. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas. c. Bertanggung jawab atas semua pelayanan Instalasi Laboratorium rumah sakit. 3. Wewenang a. Mengusulkan rencana kebutuhan Laboratorium dari segi jumlah maupun kualifikasi. b. Merencanakan kebutuhan dan mengajukan permintaan pengadaan barang – barang Laboratorium baik untuk bulanan ataupun persediaan harian.
3	Radiografer Pelaksana	1. Uraian Tugas a. Mempersiapkan pasien dan pemeriksaan 1) Melakukan identifikasi pasien (verifikasi identitas, indikasi medis dan informed consent) 2) Menjelaskan prosedur pemeriksaan Laboratorium kepada pasien dan/atau keluarga pasien. 3) Mempersiapkan pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan 4) Melakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai standar prosedur operasional (SPO). b. Mengoperasikan peralatan Laboratorium 1) Mengoperasikan peralatan Laboratorium konvensional maupun digital 2) Melakukan setting parameter eksposi sesuai kebutuhan klinis dan kondisi pasien. 3) Memastikan keselamatan pasien.

		c. Melakukan pengolahan dan penyajian hasil 1) Melakukan akuisisi, pemrosesan dan pengolahan hasil Laboratorium. 2) Memastikan kualitas citra sesuai standar diagnostic sebelum diserahkan ke dokter Laboratorium. 3) Menginput, menyimpan dan mengelola hasil Laboratorium dalam system atau media penyimpanan rumah sakit d. Melakukan manajemen keselamatan Laboratorium 1) Menggunakan dan mengawasi penggunaan alat pelindung diri (APD) 2) Meminimalkan paparan penyakit kepada pasien, petugas dan lingkungan. 3) Mematuhi protocol keselamatan e. Melakukan prosedur administrasi dan dokumentasi 1) Mencatat pelaksanaan pemeriksaan pada rekam medis pasien 2) Mengisi logbook penggunaan alat Laboratorium 3) Membuat laporan kegiatan harian, bulanan atau sesuai kebutuhan manajemen. f. Memelihara peralatan 1) Melakukan uji fungsi sederhana sebelum penggunaan alat. 2) Melaporkan kerusakan, kalibrasi atau kebutuhan pemeliharaan alat kepada alatasa/ teknisi IPSRS g. Melakukan kolaborasi dan edukasi 1) Bekerjasama dengan tim medis (dokter Laboratorium, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) 2) Memberikan edukasi singkat kepada pasien/ keluarga tentang persiapan dan tindak lanjut pemeriksaan Laboratorium 2. Tanggung Jawab a. Menjamin keselamatan pasien, petugas dan lingkungan dari bahaya paparan penyakit. b. Menyediakan hasil Laboratorium yang berkualitas tinggi untuk mendukung ketepatan diagnosis dokter c. Menjaga kerahasiaan dan rekam medis pasien. d. Melaksanakan pelayanan Laboratorium sesuai dengan kode etik profesi dan standar pelayanan rumah sakit.
--	--	--

		e. Bertanggung jawab atas keakuratan identifikasi pasien dan permintaan pemeriksaan. f. Bertanggung jawab terhadap penggunaan peralatan Laboratorium sesuai SPO dan aturan keselamatan. g. Menjamin berjalannya dokumentasi pemeriksaan sesuai standar akreditasi rumah sakit. 3. Wewenang a. Menentukan teknik pemeriksaan (posisi pasien, parameter eksposi, penggunaan kontras) sesuai permintaan dokter Laboratorium dan kondisi pasien. b. Menolak atau menunda pemeriksaan apabila terdapat kontraindikasi medis atau alasan keselamatan, dengan terlebih dahulu melaporkan ke dokter penanggung jawab. c. Menggunakan peralatan Laboratorium sesuai kompetensi yang dimiliki. d. Mengekses, mengolah dan mengarsipkan hasil pemeriksaan Laboratorium. e. Memberikan informasi teknis pemeriksaan Laboratorium kepada pasien, keluarga atau tenaga kesehatan lain. f. Melakukan tindakan emergensi sederhana saat pasien mengalami kejadian tak terduga selama pemeriksaan (misalnya reaksi kontras, sesak, sinkop) sebelum dirujuk ke dokter penanggung jawab.
--	--	---

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

6.1 Tata Hubungan Kerja

1. Hubungan Kerja dengan Direktur Rumah Sakit
 - a. Kepala Instalasi Laboratorium bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
 - b. Kepala Instalasi Laboratorium menyampaikan laporan kegiatan, capaian indikator mutu, penggunaan sumber daya, serta permasalahan pelayanan secara berkala.
 - c. Kepala Instalasi Laboratorium memberikan masukan kepada pimpinan rumah sakit terkait pengembangan pelayanan laboratorium
2. Hubungan Kerja dengan Komite Medik
 - a. Berkoordinasi dalam penyusunan dan evaluasi pelayanan laboratorium klinis.
 - b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan audit medis dan peningkatan mutu pelayanan.
 - c. Berpartisipasi dalam pembahasan kasus klinis yang memerlukan interpretasi hasil laboratorium.
3. Hubungan Kerja dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
 - a. Melaporkan indikator mutu laboratorium secara berkala.
 - b. Melaporkan insiden keselamatan pasien yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium.
 - c. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan program peningkatan mutu
4. Hubungan Kerja dengan Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, ICU, Kamar Operasi dan Unit Pelayanan Lain
 - a. Menerima permintaan pemeriksaan laboratorium melalui sistem yang berlaku.
 - b. Memberikan informasi mengenai persyaratan pengambilan spesimen, waktu pemeriksaan, dan waktu pelaporan hasil.
 - c. Menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium secara tepat waktu.
 - d. Melakukan komunikasi segera terhadap hasil kritis sesuai kebijakan rumah sakit.
 - e. Berkoordinasi dalam pengelolaan spesimen yang tidak memenuhi syarat
5. Hubungan Kerja dengan Instalasi Farmasi
 - a. Berkoordinasi terkait pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan reagen serta bahan habis pakai laboratorium.
 - b. Melakukan pemantauan stok dan kebutuhan bahan laboratorium.
 - c. Melakukan evaluasi penggunaan bahan yang memerlukan pengawasan khusus
6. Hubungan Kerja dengan Instalasi Laboratorium dan Penunjang Medis Lain
 - a. Melakukan koordinasi pemeriksaan diagnostik yang memerlukan kolaborasi pelayanan.
 - b. Bertukar informasi klinis yang diperlukan untuk menunjang diagnosis dan terapi pasien.
7. Hubungan Kerja dengan Unit Rekam Medis dan SIMRS
 - a. Berkoordinasi dalam pengelolaan data hasil pemeriksaan laboratorium.
 - b. Menjamin integrasi hasil laboratorium ke dalam rekam medis pasien.
 - c. Menjaga kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan yang berlaku
8. Hubungan Kerja dengan Unit Pengadaan dan Logistik

-
- a. Menyusun kebutuhan alat, reagen, bahan habis pakai, dan perlengkapan laboratorium.
 - b. Melakukan koordinasi pengadaan sesuai ketentuan rumah sakit.
 - c. Melakukan evaluasi ketersediaan dan penggunaan logistik laboratorium
9. Hubungan Kerja dengan K3RS dan PPI
- a. Melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium.
 - b. Berkoordinasi dalam pengelolaan limbah laboratorium.
 - c. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai ketentuan rumah sakit.
 - d. Melakukan pelaporan kejadian pajanan dan kecelakaan kerja.
10. Hubungan Kerja dengan Eksternal
- a. Laboratorium Rujukan
 - 1) Melakukan pengiriman spesimen pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan di rumah sakit.
 - 2) Menjamin ketertelusuran spesimen dan hasil pemeriksaan.
 - 3) Melakukan evaluasi mutu hasil pemeriksaan rujukan secara berkala
 - b. Dinas Kesehatan
 - 1) Menyampaikan laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Berkoordinasi dalam surveilans penyakit, kejadian luar biasa, dan program kesehatan masyarakat
 - c. Pemasok Alat dan Reagen
 - 1) Berkoordinasi terkait pemeliharaan alat laboratorium.
 - 2) Melaksanakan kalibrasi, validasi, dan perbaikan alat sesuai kontrak kerja.
 - 3) Melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala

BAB VII

POLA KETENAGAAN

7.1 Ketentuan Umum

Pola ketenagaan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit merupakan pengaturan jumlah, jenis, kompetensi, kualifikasi, kewenangan, serta penempatan sumber daya manusia laboratorium untuk menjamin terselenggaranya pelayanan laboratorium yang aman, efektif, efisien, bermutu, dan berkesinambungan selama 24 jam sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. Standar akreditasi rumah sakit mensyaratkan adanya analisis kebutuhan tenaga laboratorium yang memadai berdasarkan jenis pelayanan, volume pemeriksaan, kompleksitas pemeriksaan, dan kebutuhan pasien.

1. Instalasi laboratorium harus memiliki tenaga yang cukup baik dari segi jumlah maupun kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
2. Penetapan jumlah tenaga dilakukan berdasarkan:
 - a. Kelas rumah sakit.
 - b. Jenis pelayanan laboratorium yang tersedia.
 - c. Jumlah kunjungan pasien.
 - d. Beban kerja pemeriksaan.
 - e. Pelayanan gawat darurat dan pelayanan 24 jam.
 - f. Ketersediaan alat dan teknologi laboratorium
3. Pola ketenagaan harus menjamin kesinambungan pelayanan laboratorium selama 24 jam, termasuk pelayanan di luar jam kerja, hari libur, dan keadaan darurat.

7.2 Analisa Beban Kerja

Rumah sakit wajib melakukan analisis kebutuhan tenaga laboratorium secara berkala dengan mempertimbangkan:

1. Jumlah pemeriksaan per hari, bulan, dan tahun.
2. Jenis pemeriksaan yang dilakukan.
3. Waktu penyelesaian hasil pemeriksaan (turn around time/TAT).
4. Jumlah shift pelayanan.
5. Pelayanan cito dan kegawatdaruratan.
6. Risiko kerja laboratorium
7. Program pengembangan pelayanan laboratorium. Standar akreditasi secara khusus mensyaratkan adanya analisis pola ketenagaan yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Tabel 7.2.1 Analisa Beban Kerja

NO	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUME KERJA SHIFT	WAKTU YG DIBUTUHKAN		
				Detik	Menit	JUMLAH
1	ATLM	Melakukan desinfektan pada alat dan meja Analisa Laboratorium	3	0:00:00	0:05:00	0:15:00
		Melakukan Pengambilan sampel pasien rawat jalan	45	0:00:00	0:10:00	7:30:00
		Edukasi pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan sesuai dengan estimasi waktu pengerjaan	45	0:00:01	0:05:00	3:45:45
		Melakukan Pemeriksaan ECG	15	0:00:03	0:00:00	0:00:45
		Preparasi Sampel Siap Running (Centrifuge, Memindah kedalam Cup Sampel)	1100	0:00:03	0:00:00	0:55:00

		Melakukan pengerjaan sampel pasien rawat Inap	900	0:00:03	0:05:00	75:45:00
		Pengerjaan sampel Cito	40	0:00:00	0:10:00	6:40:00
		Memasukkan sampel ke dalam alat Darah Lengkap	850	0:00:01	0:00:00	0:14:10
		Pembuatan dan pengecatan Hapusan Darah	10	0:00:00	0:30:00	5:00:00
		Melakukan pemeriksaan Urine Lengkap	45	0:00:00	0:13:00	9:45:00
		Packing sampel Patologi Anatomi	8	0:00:00	0:08:00	1:04:00
		Memasukkan sampel dalam alat Elektrolit	10	0:00:03	0:05:00	0:50:30
		Memasukkan Sampel dalam alat BGA	5	0:00:03	0:02:00	0:10:15
		Melakukan pemeriksaan Feaces Lengkap	5	0:00:03	0:02:00	0:10:15
		Menyalin hasil yang di keluarkan alat ke dalam biling RS dan print hasil	1100	0:00:00	0:08:00	146:40:00
		Mencocokkan kembali hasil yang di ketik	1100	0:00:03	0:01:00	19:15:00
		Distribusi hasil pemeriksaan laboratorium ke unit lain	1100	0:00:05	0:00:00	1:31:40
2		cek stok minimal kantong darah (A10/B10/O10)	10	0:00:00	0:05:00	1:40:00
		order dropping darah ke PMI Bangil/PMI Sidoarjo/PMI Lawang	10	0:00:00	0:05:00	1:40:00
		melakukan retur kantong darah yang mendekati ED	10	0:00:00	0:10:00	3:20:00
		order kantong darah (PRC AB/TC/FFP)	10	0:00:00	0:10:00	3:20:00
		order kantong darah dengan hasil incompatible dengan dirujuk ke pmi Surabaya	1	0:00:00	0:45:00	1:30:00
		mengerjakan crossmatch cito	2	0:00:00	0:30:00	2:00:00
		mengerjakan crossmatch (comp/incomp)	2	0:00:00	1:00:00	4:00:00
		cetak hasil dan koreksi crossmatch	5	0:00:08	0:09:00	1:30:00
		Distribusi kantong darah yang sudah dicrossmatch unit peminta	2	0:00:00	0:10:00	0:40:00
Grand Total Waktu Pelayanan Per Hari						299:12:20
Jam kerja						24:00:00
Jumlah tenaga yang dibutuhkan Per Shift						12.47

BAB VIII

PROGRAM ORIENTASI

8.1 Orientasi Umum Rumah Sakit

- 1. Peserta orientasi
 - a. ATLM baru
 - b. ATLM magang atau peserta didik yang ditempatkan di Instalasi Laboratorium.
 - c. ATLM yang mengalami mutasi dari unit lain.
- 2. Waktu pelaksanaan
 - a. Orientasi dilaksanakan sebelum menjalankan tugas secara mandiri.
 - b. Dilaksanakan pada awal masa kerja sesuai jadwal yang ditetapkan rumah sakit.
- 3. Penanggung jawab
 - a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM) atau Diklat sebagai koordinator.
 - b. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
 - c. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - d. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
 - e. Unit terkait lainnya sesuai materi orientasi
- 4. Materi orientasi
 - a. Profil rumah sakit
 - b. Visi, Misi, Nilai Budaya, dan Motto
 - c. Tata Kelola dan organisasi rumah sakit
 - d. Hak dan kewajiban pegawai
 - e. Keselamatan pasien
 - f. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
 - g. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
 - h. Keselamatan dan Kesehatan kerja rumah sakit (K3RS)
 - i. Manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK)
 - j. Etika dan perilaku professional

8.2 Orientasi Khusus

- 1. Materi Orientasi Khusus

Tabel 8.2.1 Materi Orientasi Khusus

No	Jenis	Materi
1	Uraian Tugas dan Kewenangan ATLM	1. Tugas pokok dan fungsi ATLM 2. Kewenangan klinis sesuai penugasan 3. Tanggung jawab profesional 4. Kode etik profesi ATLM 5. Hak dan kewajiban tenaga laboratorium
2	Alur pelayanan Laboratorium	1. Tahap Pra Analitik a. Penerimaan permintaan pemeriksaan b. Identifikasi pasien c. Persiapan pasien d. Pengambilan spesimen e. Pelabelan spesimen f. Transportasi spesimen g. Penyimpanan spesimen 2. Tahap Analitik a. Persiapan reagen b. Kalibrasi alat c. Pemeriksaan spesimen

		d. Validasi hasil 3. Tahap Pasca Analitik a. Verifikasi hasil b. Pelaporan hasil c. Pelaporan nilai kritis d. Arsip hasil pemeriksaan
3	Pengelolaan spesimen Laboratorium	1. Jenis spesimen 2. Persyaratan spesimen 3. Kriteria penolakan spesimen 4. Penyimpanan spesimen 5. Ketertelusuran spesimen 6. Penanganan spesimen infeksius
4	Penggunaan Alat Laboratorium	1. Pengenalan alat laboratorium 2. Prinsip kerja alat 3. Kalibrasi 4. Pemeliharaan harian 5. Troubleshooting sederhana 6. Dokumentasi penggunaan alat
5	Pengendalian Mutu Laboratorium	1. Pemnatapan Mutu Internal (PMI) a. Quality control harian b. Levey Jennings Chart c. Westgard Rule d. Tindakan korektif 2. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) a. Program uji profisiensi b. Evaluasi hasil PME 3. Indikator Mutu Laboratorium a. TAT (<i>Turn Around Time</i>) b. Spesimen ditolak c. Nilai kritis d. Kepuasan pelanggan
6	Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Laboratorium	1. Sasaran keselamatan pasien 2. Identifikasi pasien 3. Pelaporan nilai kritis 4. Pencegahan kesalahan spesimen 5. Insiden keselamatan pasien 6. Pelaporan insiden
7	Pelaporan Nilai Kritis Laboratorium	1. Daftar nilai kritis 2. Mekanisme pelaporan 3. Waktu pelaporan 4. Dokumentasi read back 5. Monitoring kepatuhan pelaporan
8	<i>Point of Care Testing</i> (POCT)	1. Kebijakan POCT 2. Pengawasan POCT 3. Dokumentasi hasil 4. Quality control POCT
9	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	1. Login dan akses sistem 2. Input hasil laboratorium 3. Validasi hasil 4. Pelaporan hasil 5. Keamanan data pasien

2. Jangka Waktu Orientasi

- a. Orientasi khusus dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan
- b. Selama masa orientasi, peserta bekerja di bawah supervisi petugas yang ditunjuk

BAB IX

PERTEMUAN/RAPAT

9.1 Jenis Rapat

1. Rapat rutin Instalasi Laboratorium
 - a. Dilaksanakan secara berkala untuk membahas operasional pelayanan Laboratorium.
 - b. Minimal 1 (satu) kali setiap bulan
 - c. Agenda:
 - 1) Evaluasi pelayanan.
 - 2) Permasalahan operasional.
 - 3) Kebutuhan sarana dan prasarana.
 - 4) Program kerja instalasi.
 - 5) Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.
2. Rapat evaluasi mutu dan keselamatan pasien
 - a. Minimal 1 (satu) kali setiap triwulan
 - b. Agenda:
 - 1) Pencapaian indikator mutu.
 - 2) Insiden keselamatan pasien.
 - 3) Manajemen risiko.
 - 4) Audit pelayanan laboratorium.
 - 5) Program peningkatan mutu
3. Rapat koordinasi lintas unit
 - a. Dilakukan satu kali setiap bulan
 - b. Dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit
4. Rapat insidentil

Dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terdapat:

 - a. Kejadian tidak diharapkan.
 - b. Gangguan pelayanan.
 - c. Kerusakan alat.
 - d. Keadaan darurat.
 - e. Perubahan kebijakan atau regulasi.

9.2 Pelaksanaan Rapat

1. Persiapan rapat
 - a. Menentukan jadwal rapat.
 - b. Menetapkan agenda rapat.
 - c. Menyiapkan undangan rapat.
 - d. Menyiapkan bahan rapat.
 - e. Menyiapkan daftar hadir peserta
2. Pelaksanaan rapat
 - a. Rapat dipimpin oleh Kepala Instalasi Laboratorium atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Rapat diawali dengan pembukaan dan penyampaian agenda.
 - c. Setiap peserta diberikan kesempatan menyampaikan pendapat.
 - d. Hasil pembahasan dituangkan dalam notulen rapat.
 - e. Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3. Dokumentasi rapat
 - a. Undangan rapat.
 - b. Materi rapat.
 - c. Absensi rapat
 - d. Notulen rapat.
 - e. Dokumentasi pendukung lainnya

BAB X

PELAPORAN

10.1 Pelaporan Harian

1. Pelaporan harian memuat kegiatan pelayanan yang dilaksanakan setiap hari.
2. Meliputi:
 - a. Jumlah pasien yang dilayani.
 - b. Jumlah pemeriksaan Laboratorium berdasarkan jenis pemeriksaan.
 - c. Pemeriksaan cito.
 - d. Gangguan pelayanan.
 - e. Kerusakan alat.
 - f. Penggunaan bahan habis pakai.
 - g. Kejadian khusus selama pelayanan

10.2 Pelaporan Bulanan

1. Pelaporan bulanan memuat rekapitulasi kegiatan pelayanan selama satu bulan
2. Meliputi:
 - a. Jumlah kunjungan pasien.
 - b. Jumlah pemeriksaan berdasarkan jenis layanan.
 - c. Pemanfaatan alat Laboratorium.
 - d. Data sumber daya manusia.
 - e. Data pemeliharaan alat.
 - f. Capaian indikator mutu.
 - g. Pelaporan insiden keselamatan pasien.

10.3 Pelaporan Tahunan

1. Pelaporan tahunan merupakan laporan komprehensif pelaksanaan pelayanan Laboratorium selama satu tahun.
2. Meliputi:
 - a. Profil pelayanan laboratorium
 - b. Statistik pelayanan.
 - c. Evaluasi pencapaian program kerja.
 - d. Evaluasi mutu pelayanan.
 - e. Evaluasi keselamatan pasien.
 - f. Evaluasi SDM.
 - g. Evaluasi sarana dan prasarana.
 - h. Analisis beban kerja.
 - i. Rencana pengembangan pelayanan tahun berikutnya.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan organisasi, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta koordinasi pelayanan laboratorium guna mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh tenaga yang bertugas di Instalasi Laboratorium dapat memahami kedudukan, peran, tanggung jawab, kewenangan, serta hubungan kerja yang terjalin baik di dalam instalasi maupun dengan unit kerja lainnya di rumah sakit. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola organisasi laboratorium yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku.

Keberhasilan implementasi pedoman ini memerlukan komitmen, kerja sama, koordinasi, serta partisipasi aktif dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan laboratorium. Oleh karena itu, pedoman ini akan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, serta perubahan regulasi yang berlaku.

Semoga Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium Rumah Sakit ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan laboratorium dan pencapaian tujuan rumah sakit secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep